

COMPREENDENDO A ESQUIZOFRENIA

Conteúdo criado pela Healthline e apoiado por publicidade. [Saiba mais](#)

Esquizofrenia vs. Transtorno de Personalidade Esquizoide: Qual é a Diferença?



Medically reviewed by [Ifeanyi Olele, DO, MBA, MS, FAPA](#) — Written by [Sandra Silva](#) on November 1, 2024

[Sintomas](#) [Causas](#) [Tratamento](#) [Tendo ambos](#) [Remover](#)

A esquizofrenia envolve períodos de psicose, com sintomas como delírios e alucinações. O transtorno de personalidade esquizoide é um padrão persistente de pensamentos e comportamentos que causam sofrimento, mas não envolvem percepções distorcidas.

Esquizofrenia e transtorno de personalidade esquizoide não têm uma relação causal, nem envolvem exatamente as mesmas experiências emocionais e comportamentais.

A esquizofrenia está listada em “Espectro da esquizofrenia e outros transtornos psicóticos” no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, 5ª edição, revisão de texto (DSM-5-TR), o manual de referência para a maioria dos profissionais de saúde mental dos EUA. O transtorno de personalidade esquizoide, por outro lado, aparece em “Transtornos de personalidade”.

Isso significa que esses distúrbios têm critérios diagnósticos e abordagens de tratamento separados.

Transtornos psicóticos referem-se a condições de saúde mental que envolvem uma percepção distorcida que torna difícil para uma pessoa determinar o que é real e o que não é real no mundo externo.

Os transtornos de personalidade envolvem traços de personalidade e pensamentos, emoções e comportamentos persistentes que causam sofrimento duradouro e afetam a maneira como você vê a si mesmo e o mundo ao seu redor.

O transtorno de personalidade esquizoide é um dos 10 transtornos formais de personalidade e se enquadra no **cluster A** , um grupo de condições que o DSM-5-TR diz serem caracterizadas por pensamentos e comportamentos excêntricos, estranhos ou distantes. Transtornos de personalidade paranoica e esquizotípica também fazem parte do cluster A.

ADVERTISEMENT

INSCREVER-SE

Symptoms of schizophrenia vs. schizoid personality disorder

Estes são os sintomas formais de ambas as condições:

Esquizofrenia	Transtorno de personalidade esquizóide
Delírios (crenças falsas que não mudam apesar das evidências)	Evitação de relacionamentos próximos e significativos e intimidade, inclusive com parentes (nenhum desejo de se conectar emocionalmente com outras pessoas)
Alucinações (percepções distorcidas, como ver ou ouvir algo que os outros não conseguem)	Preferência por atividades solitárias, tempo sozinho e tarefas abstratas
Fala desorganizada (mudança de tópico para tópico ou uso de	Pouco ou nenhum interesse em experiências sexuais consigo mesmo

palavras inadequadas em ordem aleatória)	ou com outras pessoas
Comportamento desorganizado (incluindo agitação ou catatonia)	Dificuldade em encontrar alegria em atividades regulares (preferindo ser uma testemunha do que um participante na maioria das atividades)
Incapacidade de sentir prazer	Indiferença ao que os outros pensam ou dizem sobre você ou outra coisa
Afeto plano ou incapacidade de expressar emoções	Afeto plano e desapego
Pensamento desorganizado	Falta de amigos próximos ou relacionamentos significativos
Grave falta de motivação	
Retirada social	

Para chegar a um diagnóstico de esquizofrenia, um profissional de saúde mental tentará estabelecer que dois ou mais [sintomas de esquizofrenia](#) tenham sido persistentes por pelo menos 1 mês ou mais. O diagnóstico requer que pelo menos um desses sintomas seja [alucinações](#) , [delírios](#) ou fala desorganizada.

Para [transtorno de personalidade esquizoide](#) , o profissional de saúde mental precisará estabelecer um padrão de longa data de quatro ou mais dos sintomas listados acima. Eles devem estar presentes ao longo do tempo e na maioria das situações e causar um grau de sofrimento.

Os profissionais de saúde também vão querer explorar se esses sintomas são resultado de outras condições, incluindo [esquizofrenia](#) , [transtorno bipolar](#) ou [transtorno do espectro autista](#) , caso em que eles não diagnosticariam o transtorno de personalidade.

Causes of schizophrenia vs. schizoid personality disorder

Profissionais médicos ainda não estabeleceram as causas da esquizofrenia e do transtorno de personalidade esquizoide. Especialistas acreditam que uma combinação de fatores genéticos, ambientais e experienciais pode estar em jogo em ambas as condições.

Para a esquizofrenia, os fatores podem [incluir](#) :

- mudanças químicas e estruturais no cérebro
- ter um ou mais parentes próximos que receberam um diagnóstico de esquizofrenia ou outros transtornos psicóticos
- estressores ambientais, incluindo pobreza de longo prazo, deficiências nutricionais ou viver com medo

Mais pesquisas envolvendo humanos são necessárias para determinar o papel que esses e outros fatores desempenham no desenvolvimento da esquizofrenia.

As causas do transtorno de personalidade esquizóide também não são claras. Possíveis fatores de risco **incluir** ✓:

- experiências adversas na infância, incluindo negligência e abuso
- parentes de primeiro grau que receberam um diagnóstico de esquizofrenia, transtorno de personalidade esquizóide ou **transtorno de personalidade esquizotípica**
- baixos níveis de enzimas monoamina oxidase (MAO) plaquetárias no cérebro, que ajudam a equilibrar os neurotransmissores e estão associadas à sociabilidade

ADVERTISEMENT

Treatment of schizophrenia vs. schizoid personality disorder

Profissionais de saúde não consideram a esquizofrenia ou o transtorno de personalidade esquizoide como condições “curáveis”. Isso significa que eles provavelmente requerem tratamento contínuo por toda a vida para controlar os sintomas e diminuir o sofrimento.

A principal diferença no tratamento dessas condições é que o transtorno de personalidade esquizoide raramente requer medicamentos para controlar os sintomas, enquanto a esquizofrenia requer.

O transtorno de personalidade esquizoide responde bem à psicoterapia, mas pode ser difícil para alguém com a condição perceber que precisa de apoio. Se isso acontecer, a terapia pode ajudar com atrito interpessoal, desafios ocupacionais e redução de sofrimento.

The first line of [treatment for schizophrenia](#) is antipsychotic medications to reduce the frequency and intensity of symptoms like hallucinations and delusions.

Psychotherapy focusing on behavioral training, like [cognitive behavioral therapy](#), can also help reduce distress and interpersonal conflict. It may also help someone manage everyday challenges with work, school, or personal care.

Read more on [antipsychotic medications for schizophrenia](#).

Can you have both?

If you meet the diagnostic criteria for schizophrenia, you'll likely receive that diagnosis even if you have symptoms of a personality disorder.

Some people with schizoid personality disorder [develop schizophrenia](#) ✓ later on in life, but this isn't the case for everyone with the condition. In this case, the diagnosis would change from a personality disorder to schizophrenia.

Takeaway

Schizophrenia and schizoid personality disorder are two different mental health conditions. While schizophrenia involves symptoms of psychosis, like hallucinations or delusions, the personality disorder rarely, if ever, does. Both conditions may involve a degree of social withdrawal and flat affect, though.

Management is also different for schizophrenia, which often requires ongoing pharmaceutical treatment with antipsychotic medications in addition to behavioral therapy. Schizoid personality disorder doesn't

respond to medications, but some symptoms may decrease with long-term psychotherapy.

Having either condition may require ongoing management, but relief is possible, and support is available and effective.

How we reviewed this article:

 **SOURCES**  **HISTORY**

Our experts continually monitor the health and wellness space, and we update our articles when new information becomes available.

Current Version

 **Nov 1, 2024**

Written By

Sandra Silva

Edited By

Sandra Silva

Medically Reviewed By

Ifeanyi Olele, DO, MBA, MS, FAPA

Copy Edited By

Ellie-Louise Des Baux

Share this article



READ THIS NEXT

Are Autism and Schizophrenia Related?

Autism spectrum disorder and schizophrenia share similar symptoms, which could lead to misdiagnosis. Learn about key differences and the...

[READ MORE →](#)

Types of Delusions in Schizophrenia

Medically reviewed by [Matthew Boland, PhD](#)

Delusions are one of the hallmark symptoms of schizophrenia, but the type of delusion that manifests can vary from person to person.

[READ MORE →](#)

How to Manage Treatment-Resistant Schizophrenia

If you aren't responding well to several different medications, you may be experiencing treatment-resistant schizophrenia.

[READ MORE →](#)

O que saber sobre alucinações e esquizofrenia

Alucinações podem ocorrer em diversas condições, incluindo esquizofrenia.

[LEIA MAIS →](#)



Receba nossa newsletter de bem-estar

Filtre o ruído e alimente sua caixa de entrada com conselhos sobre saúde e bem-estar inclusivos e baseados em conhecimento médico.

Insira seu e-mail

INSCREVER-SE

Sua privacidade é importante para nós

Sobre nós

Mapa do site

Contate-nos

Assuntos Médicos

política de Privacidade

Integridade do conteúdo

Configurações de privacidade

Boletins informativos

Política de Publicidade

Tópicos de saúde

© 2025 Healthline Media LLC. All rights reserved. Healthline Media is an RVO Health Company. Our website services, content, and products are for informational purposes only. Healthline Media does not provide medical advice, diagnosis, or treatment. [See additional information.](#)

[Sobre](#) | [Carreiras](#) | [Anuncie conosco](#)

NOSSAS MARCAS

Linha de saúde
Notícias Médicas Hoje
Grandeista
Psicanálise Central
Bezzzy